

Adopción y actualización de guías clínicas

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Relacionar la práctica con fuentes oficiales y científicas vigentes, documentando adaptación al consultorio.

2. Alcance y condiciones de uso

Rutas de mayor frecuencia y técnicas especiales. Las rutas de este paquete son propuestas locales, no GPC oficiales ni guías ya adoptadas.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Identificar patologías y procedimientos frecuentes mediante registros reales

Identificar patologías y procedimientos frecuentes mediante registros reales. Priorizar riesgo, volumen y variación de atención, sin seleccionar una guía solo por equipo disponible.

2. Buscar primero GPC del Ministerio; cuando no exista o haya nueva evidencia, consultar fuentes

Buscar primero GPC del Ministerio; cuando no exista o haya nueva evidencia, consultar fuentes científicas nacionales o internacionales pertinentes. Registrar búsqueda, fecha, población y versión.

3. Leer la fuente completa y evaluar calidad, alcance, recursos y competencia

Leer la fuente completa y evaluar calidad, alcance, recursos y competencia. No inferir recomendaciones desde el título o abstract ni asumir que una guía de adultos aplica a menores.

4. Decidir adopción, adaptación o desarrollo, justificando diferencias locales y preservando

Decidir adopción, adaptación o desarrollo, justificando diferencias locales y preservando seguridad. Vincular cada recomendación a recursos, contraindicaciones, consentimiento y registro.

5. Documentar acta o registro de decisión con responsable, fecha, versión y autenticación

Documentar acta o registro de decisión con responsable, fecha, versión y autenticación. Socializar y verificar comprensión y aplicación; conservar bibliografía y permisos de instrumentos.

6. Revisar ante nueva evidencia, alerta o resultado adverso y con periodicidad local anual

Revisar ante nueva evidencia, alerta o resultado adverso y con periodicidad local anual. Registrar retirada de versión y cambios de ruta, evitando contradicciones entre un protocolo de equipo y una guía por diagnóstico.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Fuentes completas y versión identificada.

Preferencia normativa por GPC Minsalud cuando existen.

Adopción y evaluación real documentadas.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Tema prioritario	
Fuente y fecha	
Población y alcance	
Lectura y evaluación	
Decisión adoptada	
Adaptación y justificación	
Recursos y exclusiones	
Formación	
Auditoría de aplicación	
Fecha próxima revisión	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Prácticas seguras

Resolución 3100, 11.1.5: política, actividades, instancia proporcional, identificación, comunicación, infección, eventos y consentimiento, documentación y formación; aplicar los criterios pertinentes al servicio.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576